

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	密閉式胸腔引流術評核表	編號	A31000-Q06-F-B10
			版本	第 2.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	112 年 08 月 08 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：全院各單位的護理人員。

二、評核方式：至病人處查核或以口述或實際演練方式表現其密閉式胸腔引流術平常的觀念與技術。

三、評核內容：

1. 插管前的準備：

- a. 向病人解釋並視情況填妥檢查同意書。
- b. 打開無菌胸腔引流瓶，倒入無菌蒸餾水 300c.c.，使長管埋於水下 2-3 公分後，蓋緊引流瓶蓋。在引流瓶水位的水平線上貼一橫條膠布，並註明日期、時間、水量，再貼一直條膠布，註明刻度。

2. 插管時的護理：

- a. 醫師插入胸管後，立刻將引流管與引流瓶接好以布膠固定，並檢查各連接處是否固定、套牢、緊密。觀察胸瓶內之水柱是否通暢隨呼吸而起伏。
- b. 胸腔引流管應接於水下引流端，另一開口需打開通大氣。連接處布膠均需先貼直條，再環貼。
- c. 協助醫師用縫線將胸管固定在皮膚上後，傷口以優碘軟膏及無菌 Y 紗布覆蓋，再蓋上紗布並用 Mefix 固定。
- d. 以固定夾固定引流管，病人床旁應備有止血鉗，作為緊急狀況時使用。
- e. 觀察引流系統之功能，可請病人咳嗽，看液面是否波動，f/u CXR 確定位置。

3. 更換引流瓶：

- a. 如引流液面太高，超過 1/2-2/3，則應更換引流瓶。
- b. 以 2 支止血鉗夾緊胸管，2 支止血鉗成 90 度，將胸管與新的引流瓶水柱之開口連接接胸管標式處，移除引流瓶。
- c. 打開止血鉗，囑病人咳嗽及深呼吸，觀察水柱水面移動情形。
- d. 利用擠壓法(滾輪鉗 Milking)，保持引流管暢通。方法為一手固定近胸壁處之引流管，另一手向引流瓶方向擠壓。
- e. 以固定夾固定引流管。將引流瓶置於安全處，並保持引流瓶低於胸腔 2-3 呎(約 60-90 公分)。

4. 協助拔除胸管：

- a. 醫師戴上無菌手套，並將優碘軟膏置於 4"×4"紗布上，以備拔出後使用。
- b. 消毒胸管周圍皮膚。
- c. 教導病人深吸一口氣後閉氣，由醫師迅速拔除胸管，綁緊縫線。
- d. 迅速以優碘軟膏紗布敷於傷口處，並以 Mefix 固定之。觀察病人呼吸狀況及一般狀況。依醫囑胸管拔除後，行胸部 X 光檢查。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	密閉式胸腔引流術評核表	編號	A31000-Q06-F-B10
			版本	第 2.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	112 年 08 月 08 日
			頁數/總頁數	2/2

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容																正確率 (%)	備註
			1a	1b	2a	2b	2c	2d	2e	3a	3b	3c	3d	3e	4a	4b	4c	4d		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以－表示
 4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%